Memo: escaneo mundial (fuera de Irlanda del Norte, Inglaterra y Colombia) de episodios cortos de violencia × datos individuales

Scoping JMP · octubre 2026

Nota: ~24 búsquedas verificadas; después el presupuesto se agotó y el proxy bloqueó younglives, ICPSR, lifeinkyrgyzstan, uantwerpen, ennvih-mxfls, arxiv, ideas.repec. [V] = verificado; [NV] = no verificado.

Casos

1. **Ruanda, genocidio abril–julio 1994 (100 días). Nitidez 5/5.** Violencia: Verpoorten (2012) índices de intensidad por 1.484 sectores a partir de registros Gacaca, replicación pública [V]; versión provincia/comuna de Akresh & de Walque [V]; reorganización administrativa 2006 a reconciliar. Datos: EICV 1–5/7 (2000/01–2023/24 [NV última]) con año de nacimiento y distrito, migración (distrito de nacimiento [NV]); DHS 2000–2019/20 con GPS, sin lugar de nacimiento; censos 2002/2012 (IPUMS 10%; lugar de nacimiento [NV]); **Rwanda Mental Health Survey 2018: N=19.110 + 1.271 supervivientes, MINI, depresión mayor 12%, TEPT 3,6%** [V]; acceso y residencia en 1994 [NV]. Literatura: Akresh & de Walque (2008/2011): −0,5 años de escolaridad edad escolar [V]; Economics Letters 2017 convergencia completa en 2010; Guariso & Verpoorten censo, efecto doble [V]; Akresh, Verwimp & Bundervoet (2011) HAZ −1,05 [V]; La Mattina (2017 JDE) [NV]. La ventana 0-2/3-5 sobre salud mental, empleo y hogar en adultos de 30-36 años NO está hecha. Cohortes 1989-94 -> hoy 32-37. **Factibilidad 7/10.** Killer: localización en la infancia (>2 M refugiados 1994-97) y mortalidad selectiva masiva; salud mental con geolocalización retrospectiva solo si RMHS 2018 es accesible.
2. **Bosnia 1992-95 / Kosovo 1998-99 / Croacia.** Nitidez 4/5/3. Violencia: Bosnian Book of the Dead (~96.000 víctimas, fecha y municipio) [NV]; Kosovo Memory Book [NV]. Datos: BiH LSMS 2001 + panel 2002-04 (~3.000 hogares) sin identificador municipal público [V]; niños 0-5 en 1992-95 tenían 6-14 en 2001-04; censo 2013 sin microdatos [NV]; Kosovo LSMS 2000, MICS. Sin salud mental. Literatura: Swee (2015 EJPE); Kecmanovic (2013 JCR) [NV]. **Factibilidad 3/10.** Killer: no hay adultos con municipio de infancia.
3. **Kenia, violencia postelectoral 30 dic 2007–28 feb 2008. Nitidez 5.** Violencia: Comisión Waki, ACLED. Datos: KLPS no sirve (cohorte 1980-90; segunda generación nacida 2010-18) [V]; DHS 2014/2022 con GPS; censo 2019 (lugar de nacimiento por condado [NV]); KCPE difícil. Literatura: Gutiérrez-Romero (arXiv 2112.13849): violencia electoral 1992-2013, exposición prenatal–16 reduce estatura ~3 cm, sin efecto educación [V]. **Factibilidad 5/10.** Killer: dos meses; sin salud mental ni lugar de nacimiento.
4. **Costa de Marfil 2002-07 y 28 nov 2010–11 abr 2011 (nítido).** ACLED; DHS 2011-12 y 2021. Minoiu & Shemyakina (AER P&P 2012; JDE 2014): HAZ −0,49 in utero/primera infancia 2002-07, canal victimización económica [V]; Wayoro (2023 JID) [V]. **5/10.** Killer: cohortes de 2010-11 tienen 15 años.
5. **Timor-Leste, septiembre 1999 (~3 semanas). Nitidez 5** (dentro de ocupación 1975-99 y crisis 2006). CAVR/HRDAG por suco [NV]; DHS 2009-10/2016, censos, TLSLS [NV]. Justino,

Leone & Salardi (WBER 2014) [V]. **5/10.** Killer: N pequeño; episodios repetidos; sin salud mental.

6. **Indonesia: Aceh 1999-2005, Maluku 1999-2002, Yakarta mayo 1998.** IFLS cubre 13 provincias; Aceh excluida por violencia y Maluku por coste [V]. IFLS-East 2012: 7 provincias orientales incl. Maluku y Maluku Utara, ~2.547-2.690 hogares, ~10.759 personas, una sola ola [V]. Susenas (sin lugar de nacimiento [NV]); censo 2010 IPUMS (provincia de nacimiento). Violencia: NVMS Banco Mundial 1998-2014 por distrito [NV]. Yakarta 1998: 3 días confundidos con crisis asiática. **Maluku 5, Aceh 4.** Killer: una sola ola, sin CES-D.
7. **Nepal, insurgencia maoísta feb 1996–nov 2006 (escalada 2001). Nitidez 3.** INSEC por distrito y fecha (~13.000 muertes) [NV]. **Chitwan Valley Family Study**: desde 1995, 151 vecindarios, refrescos 2008 y 2016, estudio de salud mental 2016-18 con WMH-CIDI (N [NV]); ICPSR 4538 [V]. NLSS I-IV, DHS 2016/2022 GPS, Nepal National Mental Health Survey 2020 (MINI, N≈9.200) [NV]. Valente (WBER 2014) [V]; Valente (JHE 2015) [NV]; Pivovarova & Swee (WD 2015) [NV]. **6/10.** Killer: CVFS = un distrito; guerra de 10 años.
8. **Perú, Sendero Luminoso 1980-92 (picos 1983-84, 1989-92). Nitidez 3.** CVR (~24.000 víctimas, distrito y fecha). Censo 2007 y 2017 (IPUMS; distrito de nacimiento [NV]); ENAHO; **ENDES con PHQ-9 desde 2013, 15+** [V], sin lugar de nacimiento [NV]. Young Lives Perú demasiado tarde. León (JHR 2012) ya hace in utero/preescolar/escolar en educación. **6/10.** Killer: educación hecha; ~600.000 desplazados; ENDES sin lugar de nacimiento.
9. **Guatemala, 1981-83 (tierra arrasada; CEH 626 masacres). Nitidez 4.** CEH por municipio y fecha [NV]. Censo 2002 y 2018 (IPUMS; municipio de nacimiento [NV]); ENSMI; ENCOVI. INCAP (1962-77, Oriente) irrelevante. Chamarbagwala & Morán (JDE 2011): 22 departamentos × tres periodos, edad escolar [V]. **5/10.** Killer: sin salud mental.
10. El Salvador, Nicaragua, Sri Lanka, Líbano: largas. **2-3.**
11. **México, narco desde dic 2006. Nitidez 3 (sin fin).** INEGI homicidios municipio-mes. MxFLS 2002/2005-06/2009-12 (depresión 15+ [NV]); ENSANUT; ENLACE/PLANEA; censo 2020 (entidad de nacimiento). Brown (2018); Brown & Velásquez (2017); Nasir (HiCN, MxFLS 1-9 años) [V]; Jarillo et al. (2016) [V]; Michaelsen & Salardi [NV]. **5/10.** Killer: sin "post", trillado.
12. **Sudáfrica 1990-94.** Bt20/Bt30: 3.273 díadas, 1990, Soweto, >22 olas, salud mental a 14/17/22/28 [V]; ya hay paper de estrés prenatal por violencia del apartheid. Cohorte única -> no hay cohorte × lugar. NIDS 2008-17 (CES-D-10). **3/10.**
13. Uganda LRA: larga; SWAY no es primera infancia. **4.**
14. Israel/Palestina, 2ª intifada: sin post. **3.**
15. **Chile 1973 (muy nítido: ejecuciones sept-dic 1973; Rettig/Valech por comuna; censo 2017 con comuna de nacimiento [NV]; ENS 2016-17 CIDI-SF; ELSOC PHQ-9 [NV]).** Cohortes 1970-74 hoy 52-56; sin paper de primera infancia. **5.** España ETA 3; Argentina 3.
16. Ucrania, Georgia 2008, Armenia: **2-3.**
17. Nigeria Boko Haram sin fin; Biafra ya hecho con edad (Akresh et al. JHR 2023) [V]. Eritrea-Etiopía: Young Lives Etiopía cubre Tigray [V] pero <150 niños -> inviable. **Bajo.**
18. Camboya: Islam et al. (JCE 2016) hecho; sin salud mental. **3.**
19. **India Gujarat 27 feb–marzo 2002.** IHDS 2005 (41.554 hogares) y 2012 panel, IHDS-3 en

curso [NV]; sin lugar de nacimiento ni SDQ [NV]; cohortes 1999-2002 hoy 24-27. Sin paper económico de primera infancia encontrado [V]. **5.**

20. Brasil Pelotas, Filipinas: **2.**
21. **Pakistán, Swat: talibanes 2007-feb 2009, Operación Rah-e-Rast mayo-julio 2009, 2 M desplazados, 172 escuelas destruidas** [V]. PDHS, PSLM, MICS KP [NV]; sin lugar de nacimiento ni salud mental. Sin paper econométrico [V]. **5.**
22. Tayikistán (Shemyakina) [V]; **Kirguistán, Osh 10-14 junio 2010 (nitidez 5) × panel Life in Kyrgyzstan desde otoño 2010 (3.000 hogares, olas 2010-13, 2016, 2019 [NV])**: cohortes aún niños; Burundi 1993; Zimbabue Gukurahundi 1983-87 [NV].

Cohortes infantiles con salud mental en países con episodio nítido posterior

- CVFS Nepal (1995; WMH-CIDI 2016-18) -> 1996-2006: la mejor coincidencia [V].
- Bt20 Sudáfrica (1990) -> 1990-94, cohorte única [V].
- MxFLS (2002) -> narco 2007+ [NV instrumento].
- Life in Kyrgyzstan (2010) -> Osh 2010 [NV].
- Young Lives Etiopía (2002) -> Tigray 2020-22, cohorte ya adulta.
- IFLS (1993; CES-D-10 en 2014) -> sin episodios en sus provincias.
- KLPS Kenia -> respondientes 17-33 en 2007-08.
- Transversales adultas con salud mental: ENDES Perú (PHQ-9) [V]; RMHS Ruanda 2018 [V]; Nepal NMHS 2020 [NV]; Chile ENS/ELSOC [NV]; NIDS (CES-D-10) [NV].

Ranking

#	Episodio	Nitidez	Violencia	Individuales	Salud mental	Ya hecho (0-2 vs 3-5)	Factib.	Killer
1	Ruanda 1994	5	Gacaca por sector [V]	EICV, DHS-GPS, censos, RMHS 2018	Sí (MINI)	Educación sí; adultos/SM no	7	Lugar de infancia + selección por mortalidad/migración
2	Perú 1980-92	3	CVR distrito-fecha	Censo 2017, ENAHO, ENDES-PHQ-9	Sí	Educación sí (León)	6	12 años, dos picos; ENDES sin lugar de nacimiento
3	Nepal 1996-2006	3	INSEC	CVFS+CIDI, NLSS IV, DHS 2022, NMHS 2020	Sí	No	6	CVFS un distrito; inicio difuso
4	Maluku 1999-2002	4	NVMS	IFLS-East 2012, Susenas, censo	No	No	5	Una ola; sin SM
5	Guatemala 1981-83	4	CEH municipio	Censos 2002/2018, ENCOVI	No	Departamento × escolar	5	Sin SM
6	Kenia 2007-08	5	Waki/ACLED	DHS, censo 2019	No	Parcial	5	2 meses
7	Timor-Leste 1999	5	CAVR	DHS, censos	No	Escolar sí	5	N pequeño
8	Costa de Marfil 2010-11	5	ACLED	DHS	No	2002-07 sí	5	Cohortes de 15
9	Swat 2007-09	4	GTD/BFRS	PDHS, PSLM	No	No	5	Sin lugar de infancia
10	Chile 1973	5	Rettig/Valech comuna	Censo 2017, ENS, ELSOC	Sí	No	5	N modestos en SM
—	México 2007-	3	INEGI	MxFLS, PLANEA	Sí	Parcial	5	Sin post
—	Bosnia/Kosovo	4-5	RDC/HLC	LSMS, MICS	No	No	3	Sin adultos con municipio
—	Sudáfrica Bt20	3	—	Bt20, NIDS	Sí	Prenatal sí	3	Cohorte única

Justificación del top 5: Ruanda es el único caso con nitidez 5, intensidad a escala de sector pública, cohortes hoy adultas (32-37) y encuesta nacional de salud mental con instrumento diagnóstico; la ventana 0-2 vs 3-5 sobre depresión/TEPT, empleo y hogar es terreno libre; el riesgo es la selección (mortalidad diferencial hasta 10% y retornos masivos) y el acceso al RMHS 2018 con residencia en 1994. Perú combina CVR + censo con distrito de nacimiento + PHQ-9; pierde por duración y porque León ya explotó educación. Nepal tiene los mejores instrumentos (CIDI en CVFS, MINI en NMHS) pero variación local limitada. Maluku: episodio acotado, NVMS, IFLS-East 2012 con niños 10-15 nacidos 1997-2002 (exactamente 0-2 vs 3-5), pero una ola sin salud mental. Guatemala: pico concentrado, CEH municipal, censos con municipio de nacimiento, sin salud mental.

Verificaciones pendientes: sitios de Young Lives en Tigray; N del módulo CIDI del CVFS; distrito/municipio de nacimiento en censos de Ruanda 2012, Perú 2017, Guatemala 2018 y en ENAHO/EICV; olas de Life in Kyrgyzstan; escala de depresión en MxFLS; Michaelsen & Salardi y Pivovarova & Swee; acceso a RMHS 2018 y NMHS 2020; ventanas exactas de León (2012).